Тема 15. СНОТВОРНЫЕ, ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ И ПРОТИВОПАРКИНСОНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Вопросы для самостоятельной подготовки

1. Сон, физиологическое значение. Причины и формы нарушения сна.
2. Снотворные средства. Классификация и механизмы действия основных групп снотворных средств. Показания к применению, возможные побочные эффекты.
3. Эпилепсия: причины, формы, основные проявления и прогноз.
4. Классификация противоэпилептических средств. Механизм действие основных групп.
5. Противоэпилептические средства, действующие на ГАМК-эргическую систему ЦНС: группы, показания, побочные эффекты и противопоказания.
6. Противоэпилептические средства, блокирующие Na-каналы нейронов: особенности, показания, побочные эффекты и противопоказания
7. Паркинсонизм: распространённость, причины, проявления, принципы патогенетической фармакотерапии паркинсонизма.
8. Леводопа как основной препарат для лечения паркинсонизма: механизм действия и побочные эффекты.
9. Дополнительные препараты для лечения паркинсонизма (Амантадин, Бромокриптин, Карбидопа, Пирибедил, Разагилин и др.) механизм действия, показания и побочные эффекты.

Рекомендуемы темы презентаций

(необязательное задание)

- Антагонисты гистаминовых рецепторов как снотворные средства.
- Препараты мелатонина – фармакологические эффекты и показания к применению.
- Лечение отравлений, вызванных снотворными различных фармакологических групп.
- Новые противоэпилептические средства.
- Особенности лечения эпилептического статуса.

Ситуационные задачи

Решите ситуационные задачи, кратко ответьте на вопросы.

I. Пациенту с жалобами на плохой сон, раздражительность был назначен препарат. Через три дня после ежедневного приёма препарата пациент отметил значительное улучшение: нормализовался сон, уменьшилась раздражительность, появилось стремление к профессиональной деятельности.
   1) Предположите какой препарат был назначен пациенту?
   2) Каков механизм его действия?
   3) Опишите в чём преимущества назначенного препарата?

II. По поводу бессонницы пациенту был назначен фенобарбитал: по 2 таблетки (200 мг) за час до сна. Через 3 недели постоянного приёма больной предъявил жалобы на не высыпание, сонливость днём и ослабление снотворного эффекта препарата вечером.
    1) Объясните причину возможного ослабления снотворного эффекта препарата.
    2) Опишите фармакологические эффекты фенобарбитала и его механизм действия.
    3) Перечислите побочные эффекты используемого препарата и меры их профилактики.

III. В клинику скорой помощью были доставлены одновременно два пациента: один с отравлением бензодиазепинов, другой - барбитуратами.
    1) Укажите симптоматику отравления. Будет ли разница в симптоматике отравления данными препаратами?
    2) Какие меры помощи следует применить для лечения отравления?
    3) Есть ли разница в лечении отравления бензодиазепинами и барбитуратами?

IV. Пациент 65 лет по поводу болезни Паркинсона в течение длительного времени (более 2- х лет) принимает препарат леводопа в дозе, превышающей средне терапевтическую дозу – 6 г/сут. В последнее время отмечает снижение эффективности препарата, появлении неконтролируемых движений, раздражительность, головокружении усиливающееся при изменении положения тела, ощущения перебоев в работе сердца и постоянный жидкий стул, с дискомфортом и болями в эпигастрии.
    1) Определите и объясните все ли нежелательные симптомы связаны с приёмом леводопы?
    2) Что необходимо предпринять в данной ситуации?
    3) В чём состоит разница между карбидопой и леводопой, и почему карбидопа применяется только в комбинированных с леводопой препаратах?

Тестовые задания

1. Бензодиазепины обладают следующими фармакологическими эффектами:
    1) Седативным
    2) Снотворным
    3) Центральным миорелаксирующим
    4) Противосудорожным

2. Бензодиазепины могут применяться:
    1) В составе премедикации
    2) Как антиконвульсанты
    3) Для снятия стресса перед выступлением

3. Бензодиазепины могут вызвать:
    1) Аналгезию
    2) Беспокойство
    3) Безразличие

4. Длительное применение барбитуратов ведет к:
    1) Привыканию
    2) Зависимости
    3) Индукции микросомальных ферментов гепатоцитов
    4) Подавлению активности микросомальных ферментов печени

5. Барбитураты в гипнотических дозах вызывают:
    1) Легкую седацию
    2) Глубокий сон
    3) Противосудорожный эффект

6. Укажите правильные утверждения:
    1) Мидозалам-бензодиазепин кратковременного действия
    2) Диазепам применяют при эпилептическом статусе
    3) Реладорм - комбинированный препарат, содержащий барбитурат и БДП

7. Отравление барбитуратами сопровождается:
    1) Длительным бессознательным состоянием
    2) Кратковременным бессознательным состоянием
    3) Депрессией дыхания
    4) Развитием галлюцинаций

8. Не вызывают сонливости следующие противоэпилептические препараты:
    1) Фенобарбитал
    2) Этосуксимид
    3) Дифенин

9. Фармакологические эффекты барбитуратов включают:
    1) Снижение психомоторных реакций
    2) Противосудорожное действие
    3) Антипаркинсоническое действие
    4) Антипсихотическое действие

10. Противосудорожным действием обладают следующие ЛС:
    1) Аналептики
    2) Бензодиазепины
    3) Барбитураты

11. Укажите правильное утверждение:
    1) Барбитураты не должны использоваться в лечении бессонницы
    2) Барбитураты являются препаратами выбора в лечении бессонницы
    3) Барбитураты используют в лечении эпилепсии

12. Отравления барбитуратами лечат:
    1) Форсированным диурезом
    2) Искусственной вентиляцией легких
    3) Кардиостимулирующими средствами

13. Укажите правильные утверждения:
    1) Барбитураты изменяют естественную структуру сна
    2) Барбитураты вызывают сон, близкий к физиологическому
    3) После применения барбитуратов отмечается затрудненное пробуждение
    4) Барбитураты способны вызывать зависимость

Выписать рецепты

1. Фенобарбитал
2. Зопиклон
3. Дифенин
4. Нитразепам
5. Этосуксимид
6. Леводопа
7. Вальпроат натрия
8. Мелаксен

Выпишите рецепты

1. Фенобарбитал Phenobarbital (род. Phenobarbitali) – таблетки
2. Зопиклон Zopiclone (род. Zopicloni) – таблетки, покрытые пленочной оболочкой
3. Доксиламин Doxylamine (род. Doxylamini) – таблетки, покрытые пленочной оболочкой
4. Мелатонин Melatonin (род. Melatonini) – таблетки, покрытые пленочной оболочкой
5. Леводопа + Бенсеразид Levodopa + Benserazide (род. Levodopi + Benserazidi) – капсулы
6. Вальпроевая кислота Valproic acid (род. Acidi valproici) – таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой